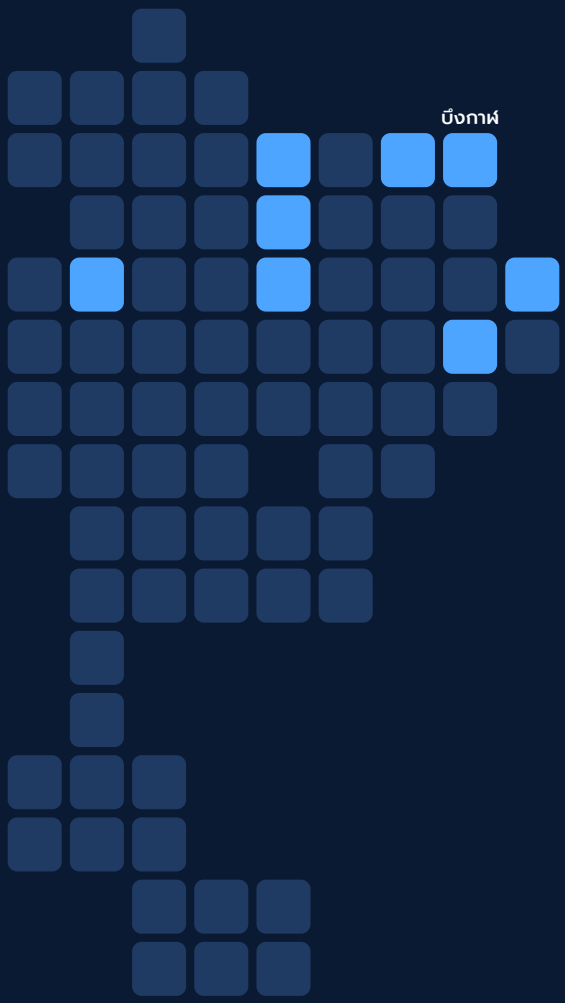
ความก้าวหน้า ไม่เดินทางเอง

หมอและพยาบาลเพิ่มขึ้นจริงตลอดสิบสองปี แต่ความก้าวหน้าไม่ได้ไหลไปถึงทุกจังหวัดเอง มันไหลไปตามตำแหน่ง เงิน และทีม ถ้าไม่ออกแบบ มันจะไหลไปหาที่ที่มีอยู่แล้ว



> **"ตำแหน่งคือรูปธรรมของความรับผิดชอบที่รัฐยอมผูกพันไว้ล่วงหน้า"**
>
> จากรายงานผลการวิจัย

8 จังหวัดสีฟ้า คือ บึงกาฬ, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, กำแพงเพชร, อำนาจเจริญ, ยโสธร, เลย, สกลนคร อยู่ในกลุ่มแพทย์ต่อตัวหารต่ำสุด ไม่ว่าจะวัดด้วยประชากร บริการ บริการคาดหมายมาตรฐาน หรือภาระโรค

หนึ่งช่องคือหนึ่งจังหวัด วางตามตำแหน่งบนแผนที่โดยประมาณ ไม่รวมกรุงเทพมหานคร

45,937

แพทย์ทุกสังกัด พ.ศ. 2568

เพิ่มจาก 26,767 คนใน พ.ศ. 2556

8

จังหวัดที่ต่ำทุกไม้บรรทัด

บึงกาฬต่ำสุดทุกครั้ง ไม่ว่าจะวัดแบบใด

0.437

ความเพียงพอของจังหวัดกลุ่มล่าง เมื่อวางตำแหน่งใหม่ตามความจำเป็น

เทียบ 0.390 เมื่อเพิ่มตำแหน่งเท่ากันตามสัดส่วนเดิม

16%

ผู้ปฏิบัติงานที่คิดออกภายในสามปี

จากผู้ตอบ 734 คนใน 66 จังหวัด

ทำไมความก้าวหน้าจึงไปไม่ถึง

โครงการนี้ถามว่ากำลังคนด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นตอบความรับผิดชอบแบบใด และไปถึงพื้นที่ใด เราวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคน บริการ ภาระโรค และการเข้าออกของบุคลากร สร้างแบบจำลองแบ่งแพทย์ใหม่ให้ 76 จังหวัดภายใต้กรอบตำแหน่งจริง และสำรวจผู้ปฏิบัติงาน 734 คน ฉบับนี้สรุปสิ่งที่พบ ข้อเสนอ และคำถามที่สังคมต้องตัดสินร่วมกัน

ในฉบับนี้

1 ห้าข้อค้นพบ จากการนับ สู่ตำแหน่ง และผู้ทำงาน
2 ข้อเสนอเจ็ดข้อที่ต้องทำเป็นชุด
3 สี่ข้อถกเถียงสำหรับการตัดสินร่วม
4 อ่านแบบจำลองอย่างตรงไปตรงมา

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ห้าข้อค้นพบ

จากการนับ สู่ตำแหน่ง และผู้ทำงาน

แต่ละข้อมีตัวเลขหลักและกราฟหนึ่งภาพ อ่านรายละเอียด วิธีคำนวณ และข้อจำกัดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ

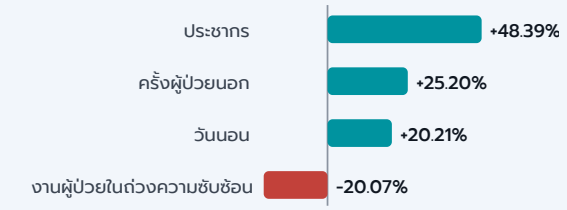
ข้อค้นพบที่ 1

นับอย่างไร คือการเลือกว่าใครต้องรับผิดชอบ

แพทย์กระทรวงสาธารณสุขชุดเดียวกันเพิ่มร้อยละ 48.39 เมื่อเทียบกับประชากร แต่ลดลงร้อยละ 20.07 เมื่อเทียบกับงานผู้ป่วยในที่ถ่วงความซับซ้อน การนับเฉพาะแพทย์กระทรวงทำให้ความหนาแน่นต่ำกว่าการนับทุกสังกัดร้อยละ 48.0 รายชื่อจังหวัดที่ขาดจึงเปลี่ยนตามไม้บรรทัด มี 41 จังหวัดที่เคยต่ำตามตัวหารอย่างน้อยหนึ่งชนิด แต่มีแกนร่วม 8 จังหวัดที่ต่ำทุกตัวหารหลัก

-20.07% แพทย์กระทรวงต่องานผู้ป่วยในที่ถ่วงความซับซ้อน ขณะที่ต่อประชากรเพิ่มร้อยละ 48.39

แพทย์กระทรวงชุดเดียวกัน เปลี่ยนไปร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบกับ



ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของแพทย์สังกัดกระทรวงต่อตัวหาร งานผู้ป่วยในถ่วงความซับซ้อนเทียบได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2561

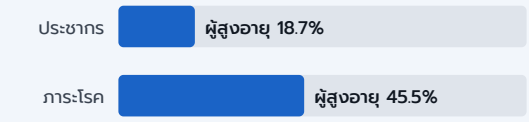
ข้อค้นพบที่ 2

ที่ไหนป่วยหนัก ที่นั่นมักมีหมอน้อย

ผู้สูงอายุเป็นร้อยละ 18.7 ของประชากร แต่รับภาระโรคร้อยละ 45.5 ภาระโรคคาดหมายจึงโตร้อยละ 21.1 ขณะที่ประชากรเปลี่ยนเพียงร้อยละ 2.0 และแพทย์ยังเอนไปอยู่ในจังหวัดที่ภาระต่ำ ดัชนีการกระจุกตัวเท่ากับ -0.111 การเลือกระหว่างตัวหารจากบริการกับจากภาระโรคจึงเป็นการเลือกเชิงคุณค่า

45.5% ของภาระโรคอยู่กับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเพียงร้อยละ 18.7 ของประชากร

ผู้สูงอายุ: ส่วนของประชากรเทียบส่วนของภาระโรค



ผู้สูงอายุคืออายุหกสิบปีขึ้นไป ภาระโรคจากการศึกษาภาระโรค ค.ศ. 2022

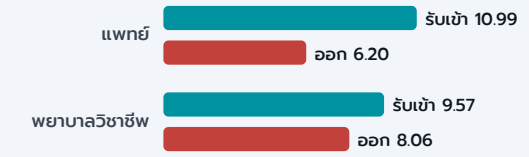
ข้อค้นพบที่ 3

ทรัพยากรดึงทรัพยากร และถังยังรั่ว

แพทย์เฉพาะทางร้อยละ 63.5 อยู่ในสถานพยาบาลหนึ่งในสิบที่มีแพทย์เฉพาะทางมากที่สุด เพิ่มจากร้อยละ 61.6 แม้เติมตำแหน่งนายแพทย์ครบทุกตำแหน่ง แพทย์ต่อประชากรยังต่างกัน 3.4 เท่าระหว่างจังหวัด ขณะเดียวกันต่อพยาบาลร้อยคนต่อปี มีการรับเข้า 9.57 ครั้งและออก 8.06 ครั้ง พยาบาลจึงโตช้าเพราะต้องทดแทนคนที่ออก ไม่ใช่เพราะรับน้อย การผลิตเพิ่มอย่างเดียวจึงไม่พอ

0.84 การออกต่อการรับเข้าของพยาบาลวิชาชีพ เทียบ 0.56 ของแพทย์

การรับเข้าและการออก ต่อบุคลากรร้อยคนต่อปี

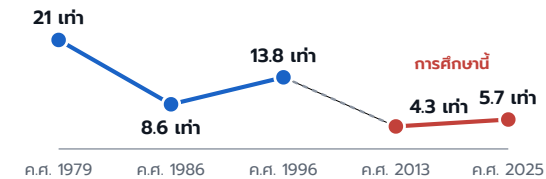


เหตุการณ์ต่อบุคลากรร้อยคนต่อปี ปีงบประมาณ 2560–2568 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วงจรสะสมหยุดได้ ถ้ามีแรงจากภายนอกที่มีทิศ

Gunnar Myrdal อธิบายว่าพื้นที่ที่ได้เปรียบดึงทรัพยากรเพิ่มขึ้นเป็นวงจร ประวัติของไทยบอกว่าวงจรนี้เปลี่ยนทิศได้ การบังคับชดใช้ทุนและการลงทุนในระบบบริการชนบทเพิ่มโรงพยาบาลชนบทจาก 200 เป็น 425 แห่ง และแพทย์ชนบทจาก 300 เป็น 1,162 คน ความต่างระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกรุงเทพฯ จึงหดลง ก่อนจะกว้างขึ้นอีกเมื่อแรงดึงของภาคเอกชนกลับมา และในข้อมูลของการศึกษานี้ ความต่างเพิ่มจาก 4.3 เท่าใน พ.ศ. 2556 เป็น 5.7 เท่าใน พ.ศ. 2568

แพทย์ต่อประชากรของกรุงเทพฯ เป็นกี่เท่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ค.ศ. 1979–1996: Wibulpolprasert และ Pengpaibon 2003 อ้างในรายงานผลการวิจัย บันทึกเชิงพรรณนา ไม่ได้ยืนยันสาเหตุ · ค.ศ. 2013 และ 2025: ข้อมูลของการศึกษานี้ (แพทย์ทุกสังกัด ประชากรทะเบียนราษฎร) ต่างแหล่งจากชุดเดิม เทียบได้ในระดับขนาด

ความก้าวหน้าไม่เดินทางเอง

ข้อค้นพบที่ 4

เมื่อกรอบเต็ม กรอบคือสูตรจัดสรร

ถ้ากรอบตำแหน่งไม่ขยาย ตำแหน่งว่างจะเต็มภายในสามปี และมีแพทย์ใหม่ 5,442 คนที่ไม่มีตำแหน่งรองรับ จะแบ่งตามสูตรใด จังหวัดกลุ่มล่างก็ได้ 0.337 เท่ากัน คันโยกจึงอยู่ที่การวางตำแหน่งใหม่ ตำแหน่ง 4,559 ตำแหน่งที่วางตามความจำเป็นยกกลุ่มล่างเป็น 0.437 ส่วนการเพิ่มตามสัดส่วนเดิมได้ 0.390 และต้องใช้ตำแหน่งราว 2.0 เท่าจึงได้ผลเท่ากัน ใครจ่ายก็สำคัญ ลูกจ้างที่โรงพยาบาลจ้างเองได้ 0.396 แต่ลูกจ้างจากงบส่วนกลางที่วางตามความจำเป็นได้ 0.488

2.0 เท่า ตำแหน่งที่ต้องใช้ ถ้าเพิ่มตามสัดส่วนเดิมให้ได้ผลเท่าการวางตามความจำเป็น

ความเพียงพอของจังหวัดกลุ่มล่าง พ.ศ. 2583 ภายใต้กติกาตำแหน่งต่างกัน



แบบจำลองจัดสรรแพทย์ ฉากทัศน์เชิงสำรวจ ไม่ใช่การพยากรณ์

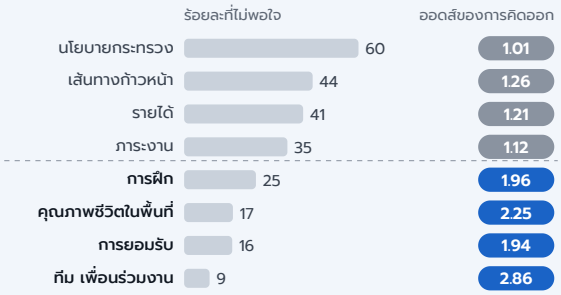
ข้อค้นพบที่ 5

สิ่งที่ผูกคนไว้ ไม่ใช่สิ่งที่คนบ่นมากที่สุด

ผู้ปฏิบัติงานร้อยละ 16 คิดออกภายในสามปี เรื่องที่ไม่พอใจมากที่สุดคือนโยบาย กำลังคนของกระทรวงและรายได้ แต่สองเรื่องนี้ไม่แยกคนที่จะอยู่ออกจากคนที่คิดจะออก สิ่งที่แยกได้คือทีม คุณภาพชีวิตในพื้นที่ โอกาสฝึก และการยอมรับ ผู้ทำงานร้อยละ 43 ยังเป็นผู้ดูแลหลักในครอบครัวเอง เมื่อระบบลดวันนอนหรือย้ายการดูแลไปที่บ้าน ภาระจึงตกกับครอบครัวและผู้ทำงานโดยไม่มีใครนับ

2.86 ออดส์ของการคิดออกเมื่อไม่พอใจทีมและเพื่อนร่วมงาน เทียบ 1.21 เมื่อไม่พอใจรายได้

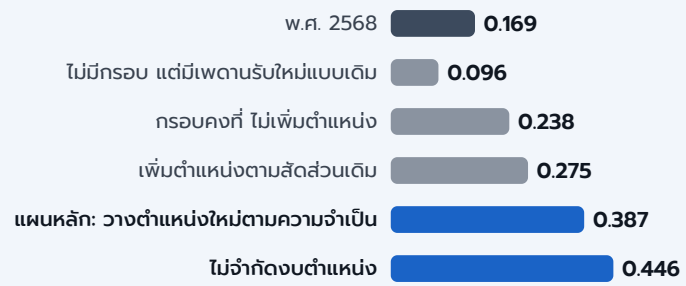
ความไม่พอใจที่พบบ่อย เทียบความไม่พอใจที่แยกผู้คิดจะออก



ออดส์ของความตั้งใจออกภายในสามปีเมื่อไม่พอใจเรื่องนั้น สีน้ำเงินคือเรื่องที่แยกผู้คิดออกได้อย่างมีนัยสำคัญ

บันไดของบึงกาฬ

บึงกาฬต่ำสุดในทุกไม้บรรทัด มีแพทย์ 72 คนและตำแหน่ง 137 ตำแหน่ง แพทย์มีโอกาสออกร้อยละ 13.4 ต่อปี ความเพียงพอใน พ.ศ. 2583 จึงขึ้นกับกติกาตำแหน่งมากกว่าสูตรใด ๆ



ความเพียงพอเทียบเป้าหมายตัวอย่าง ฉากทัศน์เชิงสำรวจ ไม่ใช่การพยากรณ์

ช่องว่างปิดได้สามทาง

1. ขีดความสามารถเพิ่มจริง
2. เปลี่ยนเป้าหมายหรือขอบเขต เช่น ตัดผู้รับบางกลุ่มออกจากตัวหาร
3. งานยังอยู่ แต่ย้ายไปให้ครอบครัวหรือวิชาชีพอื่นทำ

ทางที่สามมองไม่เห็นในบัญชีกำลังคน ผู้ทำงานสุขภาพร้อยละ 43 เป็นผู้ดูแลหลักในครอบครัวเอง รายงานความก้าวหน้าจึงควรแสดงทรัพยากรที่เพิ่ม เป้าหมายที่เปลี่ยน และภาระที่ย้ายไปคู่กันเสมอ

ข้อเสนอเจ็ดข้อที่ต้องทำเป็นชุด

ทำตามลำดับ ถ้าองค์ประกอบหนึ่งไม่ทำงาน ผลขององค์ประกอบอื่นจะลดลงแม้ใช้ทรัพยากรไปแล้ว

1. **กระทบยอดจำนวนและขอบเขตก่อนรอบจัดสรร**
   ตัวเลขที่นับคนละขอบเขตให้ภาพสถานการณ์ต่างกัน เจ้าของข้อมูลและเจ้าภาพแผนต้องระบุสังกัด พื้นที่ และวิชาชีพให้ตรงกันก่อน
2. **เปรียบเทียบแผนด้วยฐานร่วมหลายด้าน**
   เปิดผลต่อจังหวัดกลุ่มล่าง ความเหลื่อมล้ำ และพื้นที่ที่ได้และเสีย ไม่ให้แผนเป็นทั้งผู้ตั้งข้อสอบและผู้ตัดสินคะแนนของตนเอง
3. **ตัดสินตำแหน่งใหม่ทุกห้าปี วางตามความจำเป็น**
   ผูกจำนวนรับกับตำแหน่ง งบ และทีมของพื้นที่ ส่งแพทย์ใหม่ทุกปีจากตำแหน่งว่างจริง และให้ผู้จ่ายเป็นผู้วางตามความจำเป็น
4. **เชื่อมการผลิตกับเส้นทางเข้าสู่งาน**
   โควตาการผลิตในวันนี้ผูกตำแหน่งในอนาคตไว้แล้ว จำนวนรับในแบบจำลองไม่ใช่โควตาการผลิต
5. **ออกแบบการคงอยู่ตามปัญหางานและอาชีพ**
   เริ่มจากพื้นที่ทุรกันดาร การจ้างไม่มั่นคง ทีม การฝึก และการยอมรับ และผูกค่าตอบแทนกับการแก้อัตรากำลังและภาระงาน
6. **พัฒนาทีมและการดูแลต่อเนื่องโดยไม่ซ่อนภาระ**
   ติดตามงานที่ย้ายไปอยู่กับผู้ทำงานและครอบครัว เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพเห็นทั้งระบบการดูแล
7. **ตั้งวงจรทบทวนรายปีที่เหตุผลเปิดให้ตรวจ**
   ระบุจังหวัดที่ต้องให้ความสำคัญใหม่ทุกปี ประกาศเกณฑ์ตรวจล่วงหน้า และตอบข้อคัดค้านด้วยหลักฐาน

สี่ข้อถกเถียงสำหรับการตัดสินร่วม

ข้อมูลบอกได้ว่าแต่ละทางเลือกต้องแลกกับอะไร แต่ตอบแทนสังคมไม่ได้ว่าควรเลือกทางใด

1. ความจำเป็นใดควรถูกนับก่อน
2. ใครควรเป็นผู้จ้าง และอะไรกำหนดว่าพื้นที่รับคนได้เท่าใด
3. ใครรับภาระของความไม่เพียงพอ
4. ใครควรมีสิทธิ์ตัดสินว่าเท่าใดจึงเพียงพอ และฉันทามติควรสร้างผ่านช่องทางใด

อ่านแบบจำลองอย่างตรงไปตรงมา

- ✓ ผ่านเกณฑ์แรก: จำนวนแพทย์รายจังหวัดล่วงหน้าสามปีคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 28.1 คน ต่ำกว่าการใช้ค่าเดิม (33.3 คน)
- ✗ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สอง: ช่วงคาดการณ์ครอบค่าจริงเพียง 0.44 เทียบเกณฑ์ 0.80 ถึง 0.98
- ✗ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สาม: รายชื่อจังหวัดกลุ่มล่างตรงกับจริง 0.59 ต่ำกว่าเกณฑ์ 0.60

แบบจำลองจึงใช้เปรียบเทียบทางเลือกและราคาของแต่ละทางเลือกได้ แต่ไม่ควรใช้เป็นรายชื่อจังหวัดตายตัว กลุ่มจังหวัดที่ต้องให้ความสำคัญควรระบุใหม่ทุกปี ทุกแผนเป็นฉากทัศน์เชิงสำรวจ ไม่ใช่การพยากรณ์

อ่านตัวเลขในฉบับนี้อย่างระวัง

- เป้าหมายแพทย์หนึ่งคนต่อประชากรพันคนเป็นค่าอ้างอิงตัวอย่าง ไม่ใช่มาตรฐานของกระทรวง
- ความตั้งใจออกไม่เท่ากับการออกจริง และยังไม่มีการสำรวจผู้ที่ออกไปแล้ว
- ข้อมูลเข้าออกนับเป็นเหตุการณ์ ไม่ใช่จำนวนบุคคล
- บริการคาดหมายมาตรฐานคือการใช้บริการที่ปรับด้วยแบบจำลอง ไม่ใช่ความจำเป็นทางคลินิก

อ่านต่อ ทดลอง และดาวน์โหลดข้อมูล

ผลทุกข้อในฉบับนี้เปิดให้ตรวจบนเว็บไซต์ของโครงการ พร้อมกราฟ ข้อมูล และ Workforce Lab สำหรับทดลองเปลี่ยนกติกาการจัดสรรด้วยตนเอง

psitthirat.github.io/HRH-model

ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานผลการวิจัย โครงการการพัฒนาแนวทางและนโยบายการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพโดยใช้แบบจำลองบูรณาการ (ฉบับร่าง ตุลาคม 2569).

ฉบับร่างเพื่อการประชุม ตัวเลขทุกตัวผูกกับผลวิเคราะห์ชุดล่าสุดของโครงการ ทุกแผนในแบบจำลองเป็นฉากทัศน์เชิงสำรวจ ไม่ใช่การพยากรณ์